

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090674-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. SEMAGLUTIDA (OZEMPIC) - 5 CANETAS IMG/MÊS, POR SEIS MESES. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO EQUIVALENTE NO DISPENSÁRIO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5090674-27.2024.4.02.5101

510015015049 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090674-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão que indeferiu a tutela provisória para fornecimento do medicamento Semaglutida (Ozempic), com uso *off label*.

Segue a decisão agravada:

ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de antecipação de tutela e provimento final, por meio da qual a parte autora, portador de diabetes mellitus insulino-dependente e obesidade, requer a condenação da União Federal, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de fornecerem o medicamento Semaglutida (Ozempic), pelo tempo que durar seu tratamento, de acordo com as suas necessidades clínicas.

Parecer técnico acostado pelo NAT-Jus no evento 28.1.

Passo a decidir.

Inicialmente, de acordo com a documentação médica que instrui a exordial, verifico que o autor apresenta diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, obesidade e síndrome metabólica. Informa-se, também, que já fez uso de diversos medicamentos - metformina (Glifage®), glibenclamida, insulina NPH, insulina regular, insulina glargina, empagliflozina, linagliptina, liraglutida (Victoza®), dapagliflozina (Forxifa®) - todos sem sucesso. Assim, apresenta indicação para tratamento com o medicamento Semaglutida 1mg (Ozempic®).

Acerca do referido fármaco, esclarece-se que possui indicação em bula no tratamento do quadro clínico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Contudo, para o quadro de obesidade, não há indicação em bula, portanto seu uso seria off label.

Nesse aspecto, o órgão técnico esclarece o seguinte:

"O uso off-label de um medicamento significa que o mesmo ainda não foi autorizado por uma agência reguladora, para o tratamento de determinada patologia. Entretanto, isso não implica que seja incorreto. Pode ainda estar sendo estudado, ou em fase de aprovação pela

agência reguladora. Em geral, esse tipo de prescrição é motivado por uma analogia da patologia do indivíduo com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, que o médico acredite que possa vir a beneficiar o paciente. O uso off label é feito por conta e risco do médico que o prescreve.

A Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022, que dispõe sobre os processos de incorporação de tecnologias ao SUS e sobre a utilização pelo SUS de medicamentos cuja indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da ANVISA, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Excepcionalmente a ANVISA pode autorizar o uso de um medicamento para uma indicação que não conste em bula, conforme previsto no Artigo 21 do Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013. **Contudo, atualmente, não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso off label do medicamento semaglutida para o tratamento da obesidade**". (Grifei).

Acrescenta-se que o referido fármaco não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC. Desse modo, não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) disponibilizados pelo SUS no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Com efeito, para o tratamento da obesidade, o NAT-Jus destaca o seguinte:

"O tratamento do sobrepeso e obesidade no SUS é regulamentado pela Portaria SCTIE/MS Nº 53, de 11 de novembro de 2020, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Sobrepeso e Obesidade em Adultos, e envolve a atuação conjunta de diversos níveis de atenção e de apoio do SUS.

Tal PCDT preconiza o tratamento da obesidade a partir de medidas não medicamentosas, com ênfase na prática de atividades físicas, promoção de uma alimentação adequada e saudável e suporte psicológico. E, em casos específicos, pode ser indicada a realização de cirurgia bariátrica pelo SUS.

As ações da Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade (LCSO) contemplam atribuições dos componentes da Atenção Primária a Saúde (APS), da Atenção Especializada, dos sistemas de apoio e logísticos e do sistema de regulação. Pacientes com IMC < 40 kg/m² são direcionados para o atendimento e acompanhamento pela APS, enquanto pacientes com IMC ≥ 40 kg/m² ou ≥ 35 kg/m² com comorbidades são direcionados para o atendimento e acompanhamento pela Atenção Especializada.

Quanto ao quadro de obesidade, existe política pública no SUS que garante o atendimento integral aos indivíduos com tal condição. Destaca-se que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, existe Serviço Especializado de Atenção a Obesidade, conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde - CNES. O acesso aos serviços habilitados ocorre com a inserção da demanda junto ao sistema de regulação. Conforme documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 16), **o autor já se encontra em estabelecimento com Serviço de Atenção a Obesidade - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde deverá receber o atendimento integral e adequado para sua condição clínica**". (Grifei).

Pois bem.

Em relação à obrigatoriedade de fornecimento gratuito de insumos, não incluídos na listagem oficial do SUS, para tratamento da enfermidade do suplicante, é relevante a análise dos possíveis reflexos da decisão favorável à parte autora nas políticas públicas, já que não podem os recursos destinados aos programas de saúde serem distribuídos fora de um critério minimamente razoável, considerando-se o conjunto da população.

Importante ressaltar que não obstante ser a saúde direito de todos e dever do estado (art. 196 da CRFB/88), ele "é assegurado mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize."

In casu, a parte autora possui condição para a qual o SUS já disponibiliza programa específico e eficaz, de forma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração adoção de políticas de saúde diversas daquelas preconizadas pela rede pública.

Ademais, como destacado mais acima, o autor já realiza acompanhamento em Serviço de Atenção a Obesidade, junto ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, evidenciando, assim, sua devida regulação pelo SUS.

Na hipótese dos autos, resalto que o próprio documento médico apresentado pela parte autora não consigna urgência no tratamento ou agravamento do quadro clínico e risco de vida.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme fundamentação supra.

Intime-se a parte autora acerca da presente decisão.

Na mesma oportunidade, citem-se os réus para o oferecimento de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 9.099/95), devendo apresentar toda a documentação de que disponham para esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como indicando, justificadamente, as provas que pretendem produzir, ou, havendo possibilidade de conciliação, essa deve ser clara, detalhando todos os seus termos.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, pois a não realização não importa em prejuízo para as partes.

P.I.

Intimados, os réus não apresentaram contrarrazões.

VOTO

A decisão agravada se fundamentou em parecer do NAT que atesta que o medicamento não tem indicação em bula para o diabetes mellitus tipo 2, não integra nenhuma lista oficial para disponibilização e não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC.

Ainda, o NAT aponta tratamento que o Ministério da Saúde disponibiliza:

Hipoglicemiantes orais Metformina de liberação imediata (comprimidos de 500mg e 850mg), Glibenclamida (comprimido 5mg), Gliclazida 30mg (comprimido de liberação prolongada) e Insulinas NPH e Regular, fornecidos pelo Município do Rio de Janeiro, por meio da Atenção Básica

Inibidor do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) - Dapagliflozina 10mg é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) aos pacientes com DM2 em indivíduos com necessidade de segunda intensificação de tratamento com idade ≥ 40 anos e doença cardiovascular estabelecida (infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio prévia, angioplastia prévia das coronárias, angina estável ou instável acidente vascular cerebral isquêmico prévio, ataque isquêmico transitório prévio e insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%), ou; homens ≥ 55 anos ou mulheres ≥ 60 anos com alto risco de desenvolver doença cardiovascular, definido como ao menos um dos seguintes fatores de risco cardiovascular: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia ou tabagismo⁹

O tratamento do paciente com DM2 inclui também educação e conscientização a respeito da doença, estímulo para uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, orientação para metas de um controle adequado de pressão arterial, peso, lipídeos e glicêmico.

Portanto, havendo tratamento alternativo, disponibilizado pelo SUS, não há urgência nem evidência que justifiquem a reversão da tutela provisória indeferida.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, arquivem-se.